Kehamilan Postterm

Definisi, risiko, pemantauan janin, dan waktu yang tepat untuk mengakhiri kehamilan

Anandha Mardhia Prefitri · Departemen Obstetri dan Ginekologi, Universitas Hasanuddin

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah kuliah ini, mahasiswa mampu

1. Mendefinisikan kehamilan aterm lanjut dan postterm serta membedakannya dari salah penanggalan
2. Menjelaskan faktor risiko dan patofisiologi yang mendasari komplikasinya
3. Menguraikan risiko pada janin, neonatus, dan ibu
4. Memilih dan menafsirkan pemeriksaan kesejahteraan janin mulai 41 minggu
5. Menyusun rencana tata laksana: induksi atau ekspektatif, berdasarkan bukti dan pedoman

DEFINISI

Postterm berarti 42 minggu atau lebih

Early term
Aterm dini
37+0 s.d. 38+6 minggu

Full term
Aterm penuh
39+0 s.d. 40+6 minggu

Late term
Aterm lanjut
41+0 s.d. 41+6 minggu

Postterm
Postterm
42+0 minggu atau lebih (294 hari)

Dihitung dari hari pertama haid terakhir. Istilah **postdate** (lewat taksiran persalinan, lebih dari 40 minggu) dan **postmatur** (gambaran klinis bayi) bukan sinonim postterm.

Sumber: ACOG Practice Bulletin No. 146 (2014); Defining "Term" Pregnancy Workgroup

EPIDEMIOLOGI

Jarang, tetapi risikonya naik tiap minggu

5,5%

kehamilan mencapai postterm (Amerika Serikat, 2011)

0,11

lahir mati per 1.000 kehamilan pada 37 minggu

3,18

lahir mati per 1.000 kehamilan pada 42 minggu

Insidens berbeda antarpopulasi, terutama karena cara penanggalan dan kebijakan induksi setempat. USG dini menurunkan angka "postterm" yang sebenarnya salah tanggal.

Sumber: ACOG Practice Bulletin No. 146 (2014); Muglu dkk., PLoS Med 2019

Sebagian besar tanpa sebab yang jelas

SINGKIRKAN DAHULU

Salah penanggalan adalah "penyebab" tersering

Haid tidak teratur, lupa HPHT, ovulasi terlambat, tanpa USG trimester pertama

Nuliparitas	Kehamilan pertama lebih sering memanjang
Riwayat postterm	Risiko berulang pada kehamilan berikutnya
Obesitas ibu	Faktor risiko yang dapat dimodifikasi
Janin laki-laki	Sedikit lebih sering melewati taksiran
Faktor genetik	Kecenderungan dalam keluarga, dari pihak ibu
Kelainan janin (jarang)	Anensefali, defisiensi sulfatase plasenta

Sumber: ACOG Practice Bulletin No. 146 (2014)

PATOFISIOLOGI

Dua jalur menuju komplikasi

Jalur 1 · Fungsi plasenta menurun

Plasenta menua → Perfusi dan oksigenasi janin turun → Oligohidramnion, kompresi tali pusat → Hipoksia, mekonium, postmaturitas

Jalur 2 · Fungsi plasenta tetap baik

Plasenta masih adekuat → Janin terus tumbuh → Makrosomia (4.000 g atau lebih) → Distosia bahu, trauma lahir

Kedua jalur dapat terjadi pada kehamilan yang sama; cairan ketuban adalah penanda paling praktis.

RISIKO JANIN DAN NEONATUS

Yang dipertaruhkan bagi bayi

Lahir mati dan kematian neonatal

Risiko terpenting, naik progresif setelah 41 minggu

Makrosomia

Distosia bahu, cedera pleksus brakialis, persalinan dengan tindakan

Oligohidramnion

Kompresi tali pusat, pola denyut jantung janin abnormal

Sindrom aspirasi mekonium

Mekonium kental dalam cairan ketuban yang sedikit

Sindrom postmaturitas

Kulit kering mengelupas, lemak subkutan tipis, kuku panjang, noda mekonium

Morbiditas neonatal

Skor Apgar rendah, kejang, perawatan NICU

Sumber: ACOG Practice Bulletin No. 146 (2014)

RISIKO MATERNAL

Ibu juga menanggung risikonya

Laserasi perineum berat

Robekan derajat 3 dan 4, terkait bayi besar dan persalinan dengan tindakan

Perdarahan pascasalin

Uterus teregang berlebihan dan persalinan yang lama

Infeksi

Korioamnionitis dan endometritis lebih sering

Seksio sesarea

Angkanya meningkat, dengan morbiditas operasi yang menyertainya

Sumber: ACOG Practice Bulletin No. 146 (2014)

DIAGNOSIS

Diagnosis adalah soal penanggalan

Hari pertama haid terakhir

Rumus Naegele: tanggal +7, bulan −3, tahun +1. Hanya andal bila siklus teratur 28 hari dan ibu yakin tanggalnya.

USG trimester pertama

Panjang kepala-bokong (CRL) sampai 13+6 minggu adalah metode paling akurat, ketepatan sekitar 5 sampai 7 hari.

Kapan taksiran persalinan diganti dengan hasil USG

Usia kehamilan saat USG	Selisih dari HPHT
Sampai 8+6 minggu	Lebih dari 5 hari
9+0 s.d. 15+6 minggu	Lebih dari 7 hari
16+0 s.d. 21+6 minggu	Lebih dari 10 hari
22+0 s.d. 27+6 minggu	Lebih dari 14 hari
28+0 minggu atau lebih	Lebih dari 21 hari

Sumber: ACOG Committee Opinion No. 700, Methods for Estimating the Due Date (2017)

PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN JANIN

Mulai pantau pada 41+0 minggu

Pemeriksaan	Yang dinilai	Temuan yang mengkhawatirkan
Nonstress test (NST)	Reaktivitas denyut jantung janin	Nonreaktif, deselerasi berulang
Cairan ketuban (USG)	Fungsi plasenta jangka panjang	Kantong terdalam di bawah 2 cm atau AFI 5 cm ke bawah
Profil biofisik termodifikasi	NST dan cairan ketuban	Salah satu komponen abnormal
Profil biofisik lengkap	Napas, gerak, tonus, cairan, NST	Skor 4 ke bawah; skor 6 meragukan

Oligohidramnion adalah indikasi melahirkan

Tidak dilanjutkan dengan menunggu

Bukti surveilans terbatas

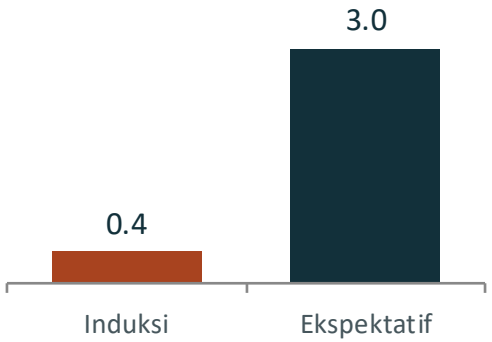
Belum ada uji acak yang menunjukkan penurunan kematian perinatal

Sumber: ACOG Practice Bulletin No. 146 (2014). AFI: indeks cairan amnion

Induksi menurunkan kematian perinatal

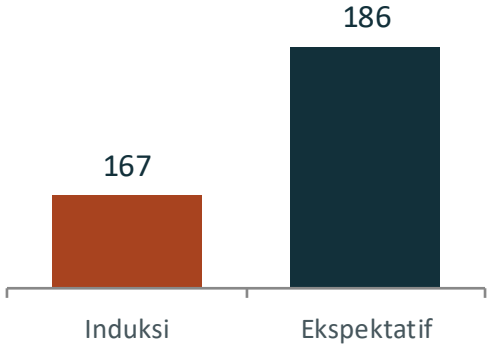
Kematian perinatal

per 1.000 · RR 0,31 (IK 95% 0,15–0,64)



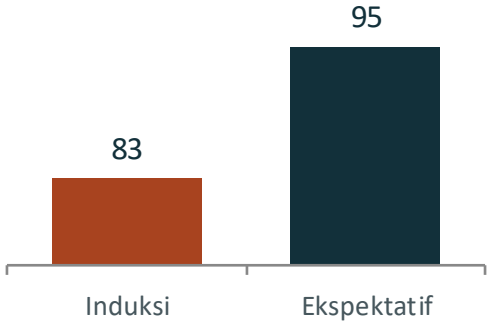
Seksio sesarea

per 1.000 · RR 0,90 (IK 95% 0,85–0,95)



Rawat NICU

per 1.000 · RR 0,88 (IK 95% 0,80–0,96)



Risiko absolutnya kecil: perlu sekitar **544 induksi** untuk mencegah satu kematian perinatal. Induksi tidak menaikkan angka seksio sesarea.

Sumber: Middleton dkk., Cochrane Database Syst Rev 2020;(7):CD004945

REKOMENDASI PEDOMAN

Pedoman bergeser ke 41 minggu

WHO 2022	**Induksi dianjurkan** bila usia kehamilan pasti sudah 41+0 minggu atau lebih. Tidak dianjurkan sebelum 41 minggu pada kehamilan tanpa komplikasi.
NICE NG207, 2021	**Diskusikan induksi** mulai 41+0 minggu. Bila ibu memilih menunggu, tawarkan pemantauan janin tambahan sejak 42 minggu.
ACOG PB 146, 2014	**Dapat dipertimbangkan** pada 41+0 s.d. 41+6; **dianjurkan** pada 42+0 s.d. 42+6 minggu. Surveilans janin mulai 41+0.

Sumber: WHO 2022; NICE NG207 (2021); ACOG Practice Bulletin No. 146 (2014)

TATA LAKSANA

Alur menurut usia kehamilan

40+0 s.d. 40+6

Pastikan dan siapkan

- Konfirmasi ulang usia kehamilan
- Konseling risiko dan pilihan
- Tawarkan stripping membran
- Ajarkan hitung gerak janin

41+0 s.d. 41+6

Pantau dan tawarkan induksi

- NST dan cairan ketuban, 1 sampai 2 kali seminggu
- Tawarkan induksi persalinan
- Lahirkan bila oligohidramnion atau NST abnormal

42+0 s.d. 42+6

Akhiri kehamilan

- Induksi dianjurkan
- Jangan melewati 42+6 minggu
- Seksio sesarea hanya atas indikasi obstetri

Cara induksi ditentukan skor Bishop

Bishop 6 ke bawah

Pematangan serviks: misoprostol dosis rendah atau kateter balon

Bishop 8 ke atas

Serviks matang: amniotomi dan oksitosin

Saat persalinan, antisipasi tiga hal

1

Hipoksia janin

Pantau denyut jantung janin secara kontinu; waspadai deselerasi variabel dan lambat

2

Mekonium

Hadirkan penolong yang terampil resusitasi neonatus sejak sebelum bayi lahir

3

Bayi besar

Taksir berat janin, siapkan penanganan distosia bahu dan perdarahan pascasalin

Pada bayi postmatur, periksa glukosa darah dan suhu: cadangan glikogen dan lemak subkutannya tipis.

RINGKASAN

Lima pesan untuk dibawa pulang

1. Postterm adalah 42+0 minggu atau lebih; aterm lanjut adalah 41+0 s.d. 41+6 minggu
2. Pastikan usia kehamilan lebih dahulu; USG trimester pertama adalah patokan terbaik
3. Risiko lahir mati, mekonium, makrosomia, dan morbiditas ibu naik setelah 41 minggu
4. Mulai 41 minggu: pantau NST dan cairan ketuban; oligohidramnion berarti lahirkan
5. Tawarkan induksi sejak 41 minggu dan jangan biarkan kehamilan melewati 42 minggu

REFERENSI

Bacaan lanjut

1. ACOG. Practice Bulletin No. 146: Management of late-term and postterm pregnancies. Obstet Gynecol 2014;124:390–6.
2. WHO. Recommendations on induction of labour, at or beyond term. Geneva: WHO; 2022.
3. NICE. Inducing labour. NICE guideline NG207; 2021.
4. Middleton P, dkk. Induction of labour at or beyond 37 weeks' gestation. Cochrane Database Syst Rev 2020;(7):CD004945.
5. Muglu J, dkk. Risks of stillbirth and neonatal death with advancing gestation at term. PLoS Med 2019;16:e1002838.
6. Wennerholm UB, dkk. Induction of labour at 41 weeks versus expectant management (SWEPIS). BMJ 2019;367:l6131.
7. Keulen JK, dkk. Induction of labour at 41 weeks versus expectant management until 42 weeks (INDEX). BMJ 2019;364:l344.
8. ACOG. Committee Opinion No. 700: Methods for estimating the due date. Obstet Gynecol 2017;129:e150–4.
9. Cunningham FG, dkk. Williams Obstetrics. Edisi ke-26. New York: McGraw Hill; 2022.